EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 83787
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-03 15:00:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE SEGUNDO TORRES FUENTES			**RUN**	: 9.528.435-3
F.Nac	: 21-07-1962	**Edad**	: 61 AÑOS, 9 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: LLAHUIMAVIDA			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-01	**Fecha Egreso**	: 2024-05-03 15:00:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Sindrome Hiperglicemico Hiperosmolar Resuelto
Neumonia Bilateral ATS III en TTO
Hipernatremia en resolución
Antec: HTA, DM2 (descompensada), Semipostrado, OH Cronico, RM?, Epilepsia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa a urgencias el dia 29/4/24 con desorientacion y disnea (traído por sobrina) posteriormente empieza a desaturar ameritando apoyo de fio2 suplementario
Se realiza TAC de torax : Extensa neumopatia multifocal bibasal de mayor ext a derecha de probable etiologia inflamatoria infecciosa, Aspirativa?
Lab Glic 615 creat 1.20 PCR 67.4 ELP 148/5.5/113 INR 1.87 PH 7.38 Pco2 25 Po3 73 Hco3 15 -- Osm serica 375
Manejo irregular de cuadro en urgencias; Evaluado por Residente UTI no encuentro nota en ficha
En sala en condiciones regulares, HDN estable, RS en monitor. Se toman nuevos controles de lab
Glic 313 creat 1.60 PCR 78.4 ELP 160/4.4/128 PH 7.33 pco2 20 Hco3 11 -- Osm serica 365//
Deshidratado, bien perfundido, moderada palidez cutaneo mucosa
Cardiopulmonar: MP+ con roncus y crepitantes bilaterales, RsCsRs NAS
Abdomen: blando, depresible, no doloroso. RH+
Extremidades: sin edema ni signos de TVP
Se desconocen datos sobre el basal del paciente y funcionalidad. En Epicrisis anterior habia sospecha de caso social
Se inicia protocolo para SHH en sala, logrando recuperación
Paciente en mejores condiciones clínicas, mas reactivo y cooperador, hidratado, neurológico vigil semiorientado, glagow 15 ptos sin focalización neurológica, (pero impresiona basal con deterioro cognitivo)
Ayer es evaluado por fonoaudióloga evalúa la deglución con papilla se aprecia seguridad y eficacia . Se retira Sng. Ademas se suspende bic de insulina, por estabilidad metabolica
Parámetros inflamatorios a la baja, mejoria de función renal, y hgt
Por lo anterior se decide su manejo en HODOM, para completar Tto ATB y kinesiterapia

PLAN DE MANEJO:

HODOM A COMPLETAR TTO ATB Y KINE
SEGUIMIENTO SOCIAL POR APS

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo asistido
2. Régimen Hiposodico Para Diabético Papilla + Liquidos ASISTIDO
3. Insulina Nph 14 Am - 8 Pm sc (Ajustar en Hodom o luego aps)
4. Ceftriaxona 2 Gr Ev Dia por 3 dias mas
5. Omeprazol 20mgrs VO dia
6. Paracetamol 500mg 2 Cada 8hrs vo Sos en caso dolor o fiebre
7. Salbutamol 2 Puff Cada 8hrs Inh por 1 semana
8. B. Ipratropio 4 Puff Cada 6hrs Inh por 1 semana
9. Brexotide 2 Puff Cada 12hrs Inh por 1 semana
10. Se Desconoce Tratamiento Crónico Para Epilepsia y otros; reiniciar el que tubiese
11. KNT Resp Y Motora X 2 en lo ideal
12. Seguimiento social y control al alta por APS

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO